

Promontofixation

Information pour le patient · Correction durable du prolapsus apical par bandelette synthétique

WARWIKI

La promontofixation (sacrocolpopexie) est l'une des corrections les plus durables du **prolapsus du dôme vaginal ou de l'utérus (apex)**. Une bandelette synthétique souple soulève le dôme vaginal et l'ancre à un ligament solide situé devant le sacrum, restaurant ainsi la position et la profondeur naturelles du vagin. L'intervention est généralement réalisée par chirurgie mini-invasive (robotique ou coelioscopique) et préserve la vie intime.

À propos de cette intervention

Une **bandelette synthétique** est fixée à la face antérieure et postérieure du dôme vaginal, puis ancrée au ligament solide situé devant le **sacrum**. Cela maintient le vagin dans sa position normale. Cette technique est considérée comme le traitement de **référence** du prolapsus apical en raison de sa durabilité.

À propos de la bandelette

La bandelette utilisée ici est posée par voie **abdominale** et bénéficie d'un solide recul scientifique en matière de sécurité. Elle est **différente** des bandelettes transvaginales (posées par le vagin) pour prolapsus qui ont fait l'objet d'alertes de la FDA et ont été retirées du marché. Votre chirurgien vous expliquera les risques, dont la rare possibilité d'exposition de la bandelette.

COMPRENDRE LES TERMES

Apex / dôme vaginal

Sommet du vagin, qui peut descendre après un accouchement ou une hystérectomie.

Sacrum

Os à la base de la colonne vertébrale ; son ligament ancre la réparation.

Bandelette synthétique

Matériau souple et permanent pour soutenir le dôme vaginal.

Robotique / coelioscopique

Chirurgie mini-invasive par quelques petites incisions.

Exposition de bandelette

Complication rare où une petite partie devient visible ; traitable.

Hystérectomie

Ablation de l'utérus, parfois réalisée en même temps.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'intervention se déroule sous **anesthésie générale** : vous ne ressentez rien pendant l'opération. Avec la chirurgie mini-invasive, la plupart des patients ont une légère douleur aux petites incisions et un inconfort lié aux gaz, et rentrent chez eux le jour même ou après une nuit. Une chirurgie ouverte nécessite un peu plus de récupération.

Comment vous préparer

- Intervention sous **anesthésie générale** — respectez les consignes de jeûne et de médicaments (arrêtez les anticoagulants si prescrit).
- Un bilan préopératoire est réalisé ; une **hystérectomie** et/ou un geste contre l'incontinence peuvent être associés.
- Ne fumez pas ; prévoyez un accompagnateur et de l'aide à domicile.

Déroulement

- 1 Vous êtes endormi(e) ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Par de petites incisions (ou une incision ouverte), la bandelette est fixée au dôme vaginal.
- 3 La bandelette est ancrée au ligament sacré, soulevant le vagin en position normale.
- 4 Une sonde urinaire est posée temporairement.

Après l'intervention

- Retour à domicile le jour même ou après une nuit ; activité légère au début.
- **Évitez les efforts, les poussées et les rapports sexuels pendant environ 6 semaines.**
- De légères pertes et un inconfort modéré sont normaux ; traitez la constipation.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Un saignement important, ou une douleur abdominale ou pelvienne qui s'aggrave
- Une **incapacité à uriner**, ou des nausées/vomissements persistants
- Des pertes vaginales malodorantes, ou des douleurs lors des rapports ultérieurs (possible problème de bandelette)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La promontofixation soulève le dôme vaginal avec une bandelette ancrée au sacrum — la correction la plus durable du prolapsus apical, généralement mini-invasive.
2. La bandelette abdominale est bien étudiée et différente des bandelettes transvaginales retirées du marché.
3. Évitez les efforts et les rapports pendant ~6 semaines. Appelez en cas de fièvre, saignement important, impossibilité d'uriner, ou pertes/douleurs tardives.